

Etablissement

Médecin

PROTOCOLE MÉDICAL PRÉÉTABLI

## Hémorragie externe

Conduite à tenir devant saignement externe abondant ou difficilement contrôlable.

### Indications

- Saignement abondant, continu ou en jet.
- Plaie avec imbibition rapide du pansement.
- Saignement chez résident anticoagulé/antiagrégé ou fragile.

### Vérifications préalables

- Protéger le sauveteur si possible : gants ou protection.
- Identifier localisation, mécanisme, abondance et traitements à risque.
- Évaluer conscience, pâleur, sueurs, malaise, pouls si possible.
- Ne pas retirer un corps étranger profond.

### Recommandations / IMPORTANT

- Ne pas faire de garrot improvisé hors urgence majeure et compétence adaptée.
- Ne pas relâcher une compression efficace inutilement.
- Ne pas nettoyer longuement une plaie qui saigne abondamment.
- Ne pas retarder l'appel au 15 en cas d'hémorragie importante.

### Conduite à tenir

- Compression directe immédiate sur la plaie avec protection.
- Allonger le résident si malaise ou saignement important.
- Relais par pansement compressif si disponible et efficace.
- Appeler aide médicale et suivre consignes du 15 si hémorragie sévère.

### Surveillance et traçabilité

- Tracer heure, mécanisme, localisation, abondance et mesures effectuées.
- Surveiller conscience, coloration, douleur, reprise du saignement.
- Noter traitements anticoagulants/antiagrégants et consignes reçues.

### Alerte immédiate

- Appel 15 immédiat si hémorragie abondante, malaise, état de choc, anticoagulant ou compression inefficace.
- Appel médical rapide pour tout saignement persistant ou plaie à évaluer.

### Mention de sécurité

La compression directe est prioritaire. Une hémorragie peut engager rapidement le pronostic vital.

Fait à : .....

Le : ..... / ..... / .....

Signature :